Éra GLP-1 si žiada nový model starostlivosti o obezitu (a čo z toho plynie pre nefrológiu)

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 05.11.2026



Ilustračná scéna. Liek je len stredom systému – bez výživy, pohybu a sledovania sa jeho prínos stráca.

Tlak na predpisovanie agonistov GLP-1 receptorov (GLP-1 RA) sa v posledných mesiacoch a rokoch výrazne zrýchlil. Medscape však v kontexte konferencie HLTH Europe 2026 upozorňuje na problém, ktorý je väčší než samotný liek: medzi tým, čo pacienti spravidla potrebujú dlhodobo, tým, ako je nastavená zdravotnícka infraštruktúra, a tým, ako spoločnosť vníma obezitu, vznikol výrazný nesúlad.

Ak chceme z liečby GLP-1 RA získať skutočný a trvalý metabolický prínos, nestačí „napísať recept“. Potrebujeme nový model chronickej starostlivosti o obezitu, ktorý bude riešiť správanie, výživu, udržanie svalovej hmoty, adherenciu aj bariéry prístupu.

Už nejde len o redukciu hmotnosti

Panelisti sa zhodli, že sa mení samotné poňatie liečby. Dôraz sa presúva od samotného poklesu hmotnosti ku komplexnej stratégii „metabolického zdravia“.

Prakticky to znamená, že v ordinácii už nejde iba o energetický deficit. Dôležitou otázkou je, ako pacientom pomôcť udržať adekvátnu výživu – dostatok vlákniny a bielkovín – a zároveň aktívne pracovať na udržaní svalovej hmoty a kvalite telesnej kompozície. Ako zdôraznila Kim Boyd (MD), v prostredí „sveta GLP-1“ treba správanie a životný štýl prispôsobiť tomu, čo je pre úspech naozaj podstatné.

Z nefrologického pohľadu je to dôležité dvojnásobne. U mnohých pacientov sa obezita premieta do kardiometabolického rizika, ktoré následne zvyšuje pravdepodobnosť progresie chronických chorôb obličiek alebo komplikuje ich manažment. Ak redukcia hmotnosti prebieha bez pozornosti venovanej svalovej hmote, môže zhoršiť funkčnú rezervu, toleranciu ochorenia a celkový zdravotný stav.

Bariéry prístupu nie sú len logistické

Medscape opisuje tri typické brzdy širšieho využívania GLP-1 RA.

Prvou je stigma. Dennis Ballwieser (MD) upozornil, že obezita je v niektorých systémoch právne aj kultúrne chápaná ako „výber životného štýlu“, a nie ako chronické ochorenie. Takýto rámec mení správanie pacientov, obmedzuje ochotu lekárov a znižuje šancu, že sa terapia bude poskytovať konzistentne a dlhodobo.

Druhou brzdou je dostupnosť. Panelisti hovorili o situáciách, keď časť pacientov môže naraziť na obmedzenia štandardnej verejnej starostlivosti, zatiaľ čo iní si liečbu zabezpečia súkromne.

Treťou je ekonomika. V článku sa uvádza príklad Spojeného kráľovstva, kde je cieľom NHS rozširovať prístup pre obmedzený počet pacientov za určité obdobie, zatiaľ čo súčasne existuje vysoký počet súkromne platených predpisov. Výsledkom je nerovnosť v tom, kto dostane metabolickú intervenciu včas.

Prečo „krátkodobý fix“ nestačí

Článok ďalej zdôrazňuje, že bez zmeny životného štýlu je dlhodobý úspech obmedzený. Údaje o prerušení liečby podľa panelistov ukazujú, že pacienti často znovu priberú väčšinu stratenej hmotnosti približne do 18 mesiacov od ukončenia.

To zodpovedá názoru, že GLP-1 RA sa nemajú vnímať len ako dočasná kúra. Ak sa obezita správa ako chronický stav s relapsom pri prerušení liečby, potom aj starostlivosť musí byť navrhnutá ako chronická. Musí teda existovať plán pokračovania, podpornej fázy a priebežného merania výsledkov, nie iba „štart“ terapie.

Ekonomické modelovanie je často mimo reality

Panelisti tvrdia, že tradičné ekonomické hodnotenia často pracujú s príliš zastaranými klinickými predpokladmi. V článku sa spomína britský model NICE, ktorý pre podporu terapie počítal s vysokým počtom stretnutí v primárnej starostlivosti.

Ich argument je jednoduchý: ak možno starostlivosť riadiť prostredníctvom digitálnych platforiem a virtuálnych konzultácií, dá sa bezpečne zvládnuť väčší objem pacientov s nižšími nákladmi. A nejde len o náklady na zdravotníctvo. V texte sa uvádza, že štruktúrovaná liečba GLP-1 viedla k zníženiu dní pracovnej neschopnosti približne o 50 % do 6 mesiacov.

Zároveň sa očakáva tlak trhu na znižovanie cien v horizonte 5 až 10 rokov, a to aj vďaka rastúcej konkurencii, viacerým formuláciám a postupnému príchodu generík. Kai Eberhardt (PhD) opisuje budúcnosť tak, že lieky na obezitu by sa mohli stať „bazálnym preventívnym“ nástrojom kardiometabolického zdravia podobne, ako spoločnosť dnes vníma statíny.

Čo by mal „nový model starostlivosti“ znamenať pre nefrológov

Ak obezitu chápeme ako chronické metabolické ochorenie, nefrológovia sa stávajú prirodzenými partnermi multidisciplinárneho tímu. Nie preto, že by sme „nahradili“ obezitologickú ambulanciu, ale preto, že máme jedinečný pohľad na riziká viažuce sa na obezitu a kardiometabolický profil.

Nový model môže v praxi zahŕňať:

- **Posun cieľov z hmotnosti na metabolické výsledky.** To znamená sledovať nielen váhu, ale aj výživu, telesnú kompozíciu a rizikové faktory relevantné pre obličky a cievy.
- **Systematickú podporu výživy a svalov.** Keďže klinickou prioritou je udržať adekvátny príjem bielkovín a vlákniny, tím by mal mať jasný postup, ako pacientovi pomôcť.
- **Kontinuálny manažment namiesto epizód.** Ak je predpoklad relapsu po ukončení, je logické mať plán dlhodobého sledovania a podpornej fázy.
- **Prepojenie s digitálnymi formami sledovania.** Článok poukazuje na to, že virtuálne a digitálne platformy môžu znižovať tlak na systém bez straty bezpečnosti.
- **Aktívne riešenie bariér prístupu.** Stigma a ekonomické nerovnosti môžu viesť k tomu, že pacienti dostanú liečbu neskoro alebo prerušovane.

Praktické dôsledky pre kvalitu starostlivosti

Z pohľadu nefrológie sa oplatí uvažovať v dvoch rovinách: kvalita výsledkov a bezpečnosť v kontexte

komorbidít.

Pokiaľ ide o kvalitu výsledkov, dáva zmysel, aby pacient s obezitou a kardiometabolickým rizikom nedostal „liečbu v zmysle predpisu“, ale liečbu v zmysle programu: nutričné vedenie, sledovanie funkcie obličiek a telesnej kompozície a jasný spôsob, ako zvládať nežiaduce účinky tak, aby sa neohrozila adherencia.

Pokiaľ ide o bezpečnosť, je dôležité, aby sa o GLP-1 RA rozhodovalo s ohľadom na celkový klinický obraz. V praxi to znamená koordináciu s ďalšími liekmi, komorbiditami a stavmi, ktoré môžu meniť toleranciu alebo hydratáciu pacienta.

Článok sám osebe nie je nefrologickým usmernením, ale poskytuje rámec s priamym dopadom na nefrológiu: ak je cieľom zlepšiť metabolické zdravie a znížiť riziko relapsu, starostlivosť musí byť nastavená ako dlhodobý program, nie ako jednorazový zásah.

Záver

Medscape v článku o ére GLP-1 ukazuje, že „nová biológia“ sama osebe nestačí. Ak má liečba priniesť dlhodobý prínos, musí sa zmeniť model starostlivosti: od redukcie hmotnosti k metabolickému manažmentu, od epizód k chronickej koordinovanej podpore a od rigidných bariér k systémom, ktoré umožnia kontinuitu.

Pre nefrológiu z toho vyplýva, že obezita nie je len sprievodný problém. Je to chronický stav s dopadom na kardiometabolické riziko a potenciálne aj na priebeh ochorení obličiek. Čím lepšie budeme prepojení s multidisciplinárnym tímom, tým väčšiu šancu máme, že výsledky budú realistické, udržateľné a bezpečné.

Zdroj: *Manuela Callari, GLP-1 Era Demands New Model Obesity Care, Medscape (2026).* *Link na zdroj.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=glp1-era-novy-model-starostlivosti-o-obezitu-nefrologia · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.